

CANVAS DE GOBIERNO DE TI

Kick-off del proyecto: presentación del reto organizacional

Gerencia y Gobierno de TI - Unidad 1 Actividad 1

Caso: Nueva EPS S.A.

Campo Ariza, Felix Mauricio – Toledo Lugo, Pablo Andrés

1. ORGANIZACIÓN SELECCIONADA Nueva EPS S.A. — Entidad Promotora de Salud, sociedad de economía mixta (Nación/MinHacienda y seis cajas de compensación: Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfandi, Comfenalco Valle y Comfenalco Antioquia). NIT 900.156.264-2. Bogotá, Colombia. • Escala: aseguradora más grande del país, ≈11,5–11,7 millones de afiliados en régimen contributivo y subsidiado. • Situación de gobierno: intervención forzosa administrativa para administrar por la Supersalud desde el 3-abr-2024; prorrogada el 10-abr-2026 hasta abril de 2027 (Res. 2026100000003814-6). Junta directiva y asamblea separadas de sus funciones (art. 116 EOSF). • Por qué es tratable desde gobierno de TI: la propia Supersalud atribuye la crisis a deficiencias en sistemas de información, rezago en cuentas médicas e incumplimiento del reporte regulatorio, no solo a finanzas. Hay evidencia pública abundante (resoluciones, Contraloría, auditoría forense, prensa sectorial).	2. PREGUNTA CENTRAL DE GOBIERNO <i>y pregunta analítica</i> Pregunta central de gobierno ¿Qué mecanismos de gobierno de TI (estructuras de decisión, políticas de gobierno de datos y control de los recursos tecnológicos) debe implementar Nueva EPS para que su capacidad de procesar, auditar y reportar la información de cuentas médicas sea oportuna, trazable y conforme con las exigencias de la Supersalud, sin comprometer la continuidad de la atención a sus afiliados? Pregunta analítica (Ciencia de Datos) ¿Qué características de las cuentas médicas (tipo de prestador, régimen, servicio, antigüedad, monto, canal de radicación) explican el represamiento y permiten priorizar su auditoría para maximizar el valor conciliado por unidad de esfuerzo? Preguntas secundarias • ¿Qué decisiones de TI se tomaron sin alineación con la estrategia (p. ej., continuidad de un sistema que no procesa el volumen)? • ¿Qué controles de calidad y trazabilidad de datos faltan para cumplir el reporte a Supersalud/ADRES? • ¿Qué riesgos surgen si se incorpora IA/analítica a la auditoría de cuentas (NIST AI RMF)?	3. CONTEXTO DEL PROBLEMA <i>evidencia pública</i> • Rezago de cuentas médicas: pasó de \$5,7 billones (abr-2024) a \$14,9 billones a dic-2025, más de 14,2 millones de facturas sin procesar. Anticipos +115 % (\$17,1 billones); deuda total ≈\$26 billones. • Tecnología: el sistema “Famisanar Integra” (≈USD 5 M/año) no procesa los ≈5 millones de facturas mensuales; en sep-2025 se contrató la implementación de Factramed (VCO) mientras el rezago se atiende manualmente vía terceros. • Cumplimiento: incumplimiento sistemático del reporte de información exigido por Supersalud desde mar-2024; carencia de estados financieros certificados; operativo de recolección forense (jul-2025) e imágenes forenses 2022–2025. • Gobernanza: alta rotación (4 interventores, 7 VP de salud, 4 VP financieros); perfiles directivos sin formación en sistemas de información y control. • Efecto en el negocio: pérdida de 314.586 afiliados (jun-2025 a mar-2026), filas y tutelas, deterioro de la red y riesgo de liquidación.
4. DIMENSIONES DE TD COMPROMETIDAS <i>preliminar</i> • Estrategia: decisiones de TI reactivas, sin PETI visible alineado al saneamiento; compra/contratación de software sin criterio de valor. • Procesos: gestión de cuentas médicas manual, tercerizada y no estandarizada; sin conciliación efectiva con prestadores. • Gestión de datos: sin trazabilidad ni calidad para reportar; información “no disponible en los sistemas” según Supersalud. • Infraestructura/sistemas: plataforma que no escala al volumen transaccional; migración en curso sin gobierno del cambio. • Cultura y estructura: rotación directiva, sin comité/estructura estable de decisión de TI. • Experiencia del usuario: impacto directo en acceso, autorizaciones y oportunidad de la atención.	5. PARTES INTERESADAS Internas • Agente especial interventor y equipo directivo (VP financiera, VP de salud, Dirección de TI, Cuentas Médicas, Revisoría Fiscal). • Colaboradores y terceros operativos (auditoría de cuentas, uniones temporales, proveedores de software VCO/Factramed). Reguladores y control • Superintendencia Nacional de Salud (interventor, reportes), ADRES (giros/UPC), MinSalud, MinHacienda (accionista mayoritario). • Contraloría General, Procuraduría, Fiscalía, Congreso (control político). Ecosistema y usuarios • ≈11,7 M de afiliados y organizaciones de pacientes (Pacientes Colombia). • IPS, hospitales y proveedores (acreedores por \$14,9 billones); cajas de compensación accionistas.	6. MARCOS DE REFERENCIA PRELIMINARES • COBIT 2019: EDM01/EDM03 (gobierno y riesgo), APO11 (calidad), APO12 (riesgo), APO14 (gestión de datos), BAI (cambio), DSS (operación). Base del mapa de brechas. • ITIL 4: gestión del servicio de cuentas médicas y del cambio en la migración de plataforma. • NIST AI RMF 1.0 / Ley de IA de la UE: referencia para gobernar la analítica/IA en priorización y auditoría de facturas (riesgo alto: decisiones con impacto económico y en acceso a salud). • Normativa colombiana: Ley 1581/2012 (datos personales), Ley 2015/2020 (HCE interoperable), Res. 2275/2023 (RIPS + factura electrónica), Circular Única y reportes de Supersalud, Decreto 780/2016. • Referencias complementarias: MRAE/MGGTI de MinTIC (aplicable por control estatal), ISO/IEC 27001, Weill & Ross (arquetipos de decisión), ODS 9 meta 9.b.
7. ALCANCE Y CRITERIOS DE ÉXITO Alcance del proyecto (14 semanas) • Incluye: gobierno de datos y sistemas del proceso de cuentas médicas y del reporte regulatorio; estructura de decisión de TI; plan de mitigación de riesgos. • Excluye: red de prestación clínica, decisiones de liquidación/recapitalización y auditoría contable. Criterios de éxito preliminares • Mapa de brechas TI-negocio validado con ≥3 dimensiones y evidencia primaria. • Modelo de gobierno propuesto con ≥3 mecanismos (estructuras, procesos, relacionales) trazados a COBIT. • Pregunta analítica respondida con ≥2 fuentes de datos abiertas y pipeline documentado en repositorio Git. • Reflexión ética (datos sensibles en salud) y vínculo con ODS 9.b.	8. ROLES DEL EQUIPO, FUENTES Y SUPUESTOS Equipo • Felix Mauricio Campo Ariza (médico, epidemiólogo): líder del proyecto; diagnóstico organizacional; analítica de datos y pipeline; redacción y repositorio Git. • Integrante 2 (por asignar): marcos de referencia (COBIT/ITIL/NIST), mapa de stakeholders, control de calidad de entregables. Nota: mientras se confirma la conformación del equipo, ambos roles son asumidos por el integrante 1. Fuentes preliminares • Supersalud (Res. 2024160000003012-6 y 2026100000003814-6; concepto técnico 27-feb-2026); Contraloría General; auditoría forense 2019–2025. • SISPRO/BDUA, datos abiertos ADRES y Supersalud, informes de gestión Nueva EPS. • Prensa sectorial verificada: ConsultorSalud, El Tiempo, Semana, Infobae, Portafolio, Razón Pública. Supuestos e incertidumbres: sin acceso a datos internos (se usan datos abiertos agregados); el cambio de Gobierno Nacional (agosto de 2026) podría modificar el agente interventor, la dirección de la Supersalud y el rumbo de la intervención; el diagnóstico se contrastará con los actos administrativos vigentes.	